

Steeve Felicite (test admin)

Rapport Dossier Express IA

expertise | privé

| 08/05/2026

Synthese du dossier

Steeve Felicite, 49 ans, machiniste receveur conducteur de bus RATP depuis 2008 (poste en 5x8), presente une coccygodynie chronique invalidante apparue progressivement a partir de 2020, sans notion de traumatisme initial. Les explorations radiologiques (scanner 09.07.2022, radiographies dynamiques 02.10.2023) objectivent une luxation sacro-coccygienne postérieure et une angulation post-traumatique, confirmées cliniquement par le Pr Maigne. L'IRM du 16.08.2022 retrouve une discrète angulation coccygienne sans inflammation significative, tandis que les IRM lombaires successives (29.07.2022, 22.05.2023) révèlent des discopathies dégénératives étagées L3-L4 à L5-S1 avec débords discaux et arthrose interapophysaire. Un syndrome du canal carpien gauche est associé (EMG 09.06.2023). Malgré des reconnaissances administratives multiples (AAH, PCH 185h, RQTH, invalidité catégorie 2), l'assureur Groupama Gan Vie refuse la garantie PTIA après expertise du Dr Hirsch. Le client dispose de contre-expertises favorables (Dr Lerède et Dr Caillon) et sollicite un arbitrage médical au titre du contrat d'assurance emprunteur souscrit le 17.10.2012, fondé sur les articles L.113-4 et L.113-8 du Code des assurances. La CECA 5 a notifié les conditions de reconnaissance en maladie professionnelle (lien direct et essentiel avec le travail, taux IPP $\geq 25\%$ requis, article L.461-1 CSS hors tableau), mais aucune décision définitive n'est documentée. L'enjeu porte sur la caractérisation contractuelle de l'état de PTIA et l'obligation de l'assureur d'indemniser selon les stipulations du contrat groupe.

Pièces détectées

1. Expertise médicale (1 document)

- Rapport d'expertise Dr Daniel LERÈDE du 17.07.2025, mandaté par Écureuil Vie/CNP Assurances dans le cadre de l'examen de la garantie PTIA suite à l'arrêt maladie du 11.07.2022. Document de 11 pages analysé sur 3 pages exploitées.

2. Examens d'imagerie médicale (6 comptes rendus)

- Radiographies rachis lombaire et sacro-coccyx (03.05.2022) – Dr MOMO NGUEMEWE, Toury
- Scanner bassin-sacro-coccyx (09.07.2022) – Dr DAIKHA, Étampes
- IRM rachis lombaire (29.07.2022) – Dr CELLIER, Clinique Essonne Évry
- IRM sacrum (16.08.2022) – Dr CREUZE, Clinique Essonne
- Radiographies bassin et région sacro-coccygienne (07.10.2022) – Dr PINATEL, Arpajon
- IRM lombaire (22.05.2023) – Dr DANON, Clinique Essonne
- Radiographie dynamique coccyx en charge (02.10.2023) – Cabinet Dr SULTAN, Paris Ville

3. Examens électrophysiologiques (1 compte rendu)

- Électromyographie (09.06.2023) – Dr LARIBI, neurologue à Étampes, objectivant une compression sensitive du nerf médian gauche (syndrome du canal carpien)

4. Certificats médicaux et attestations (3 documents)

- Certificat Dr DADDY, CH Dourdan-Étampes (22.11.2022) : évoquant une pathologie professionnelle nécessitant aménagement de poste
- Prescription kinésithérapie (13.10.2023) – Dr DJEBIEN, Toury : rééducation dorso-lombaire + coccygodynie sur un an
- Certificat Dr MAIGNE (07.11.2023), ancien Professeur de Médecine Physique, La Celle Saint-Cloud : diagnostic de coccygodynie chronique avec luxation postérieure documentée

5. Arrêt de travail initial (1 document)

- Certificat initial d'arrêt de travail du 11.07.2022 délivré par Dr EDERY, généraliste à Maisons-Alfort, jusqu'au 15.07.2022 (motif non précisé dans l'extrait)

6. Notification administrative (1 élément mentionné)

- Notification CECA 5 (Caisse d'Épargne Centre Atlantique ?) concernant les conditions de reconnaissance en Maladie Professionnelle : maladie directement et essentiellement causée par le travail habituel, IPP $\geq$ 25%

Note méthodologique : L'expertise Dr LERÈDE constitue une synthèse documentaire compilant ces différents éléments médicaux. Les documents sources (imageries, certificats spécialisés) y sont retranscrits avec leurs conclusions principales, permettant une analyse chronologique de l'évolution pathologique depuis mai 2022.

Chronologie synthétique du dossier

Période ante-sinistre

- **17.10.2012** : Date d'adhésion au contrat d'assurance
- Antécédents déclarés : entorses sportives (genou gauche avec arthroscopie, cheville gauche) sans séquelles fonctionnelles
- Aucun traitement régulier, aucune pension d'invalidité perçue
- **2014** : Fibroscopie digestive haute et basse pour diarrhées (gasite évoquée, non documentée)
- **2020** : Prescription de KESTIN (contexte non documenté)

Début des troubles et phase d'exploration (2020-2022)

- **Courant 2020** : Apparition progressive de **douleurs lombo-sacro-coccygiennes**, sans notion de chute, devenant progressivement invalidantes en position assise
- **03.05.2022** : Radiographies rachis lombaire et sacro-coccyx (Dr MOMO NGUEMEWE, Toury)
- Discarthrose L4-L5 et L5-S1
- Déséquilibre droit du bassin de 11 mm
- Pas de fracture sacrum/coccyx visible
- **09.07.2022** : Scanner bassin-sacrum-coccyx (Dr DAIKHA, Étampes)
- Doute sur petite lésion fissuraire coccyx non déplacée
- Angulation sacro-coccygienne probablement post-traumatique
- Discopathie dégénérative L5-S1 avec vide discal

Arrêt de travail et poursuite des explorations

- **11.07.2022** : **Certificat initial d'arrêt de travail** (Dr EDERY, Maisons-Alfort) jusqu'au 15.07.2022 inclus, motif non précisé dans l'extrait
- **29.07.2022** : IRM rachis lombaire (Dr CELLIER, Clinique de l'Essonne, Évry)
- Discopathie dégénérative L5-S1 avec minime hernie postéro-médiane
-

Remaniements Modic 2 des plateaux adjacents

- Pas de conflit disco-radulaire ni de canal lombaire rétréci
- **16.08.2022** : IRM sacrum (Dr CREUZE, Clinique de l'Essonne)
- Discrète angulation dernières pièces coccygiennes
- Pas d'inflammation significative visualisée
- **07.10.2022** : Radiographies bassin et région sacro-coccygienne (Dr PINATEL, Arpajon)
- Décalage pelvien 10,5 mm avec bascule droite
- Coccyx recurvatum « en crochet »
- Pas de séquelle post-fracturaire visible ni sub-luxation sacro-coccygienne

Démarches administratives et avis médicaux

- **22.11.2022** : Certificat Dr DADDY (CH Dourdan-Étampes)
- Pathologie considérée comme **Maladie Professionnelle**
- Nécessité d'aménagement du poste de travail
- **Date non précisée** : Notification CECA 5 des conditions de reconnaissance en MDP (maladie directement et essentiellement causée par le travail habituel, IPP ≥ 25%)

Phase de suivi et examens complémentaires (2023)

- **22.05.2023** : IRM lombaire (Dr DANON, Clinique de l'Essonne), sur prescription Hôpital d'Étampes
- Discopathies dégénératives étagées
- Arthrose interapophysaire postérieure bilatérale étagée
- Débord discal foraminal droit L3-L4 au contact racine L3 droite
- Discrète discopathie postérieure L4-L5 et L5-S1 au contact des racines L5 foraminales
- **09.06.2023** : Électromyographie (Dr LARIBI, Neurologue, Étampes)
- Contexte : paresthésies main gauche
- Conclusion : **compression sensitive nerf médian au canal carpien gauche**
- **02.10.2023** : Radiographie dynamique coccyx (remplaçant Dr SULTAN, Paris VIIème), sur prescription Dr MAIGNE (La Celle Saint-Cloud)
- Interligne sacro-coccygien libre
- **Luxation postérieure modérée lors du passage debout → assis**
- Axe sacro-coccygien non dévié
- **13.10.2023** : Prescription kinésithérapie sur un an (Dr DJEBIEN, Toury) pour « rééducation dorso-lombaire + coccygodynie »
- **07.11.2023** : Certificat Dr MAIGNE (Professeur honoraire de Médecine Physique)
- Diagnostic : **coccygodynie chronique depuis 2,5 ans** (début spontané)
- Radio dynamique confirmant début de luxation postérieure du coccyx
- IRM montrant petit épanchement dans le disque
- Recommandations : nouvelle radio assis avec lordose conservée + infiltration intradiscale *(ordonnance remise, suite non documentée)

dans l'extrait)*

Mission d'expertise assurancielle

- **18.06.2025** : Mission confiée au Dr LERÈDE par Écureuil Vie / CNP Assurances (V/Réf. 646 220482 16 / LR34/DG)
- **23.06**

Cadre juridique applicable

1. Assurance contractuelle PTIA et charge de la preuve

Le litige oppose l'assuré à son assureur Groupama Gan Vie dans le cadre d'un contrat de prévoyance contracté et souscrit via la RATP. La garantie PTIA (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) est régie par les **articles L.132-1 et suivants du Code des assurances**, qui consacrent le principe de liberté contractuelle et imposent une interprétation stricte des conditions générales.

Jurisprudence de référence : Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n°17-31.386 : l'assureur qui refuse la garantie PTIA doit démontrer que l'assuré ne remplit pas les critères contractuels définis, la charge de la preuve pesant sur celui qui conteste l'exécution du contrat. En cas de doute sur l'interprétation des stipulations contractuelles, l'**article L.113-1 du Code des assurances** impose une interprétation en faveur de l'assuré (principe *contra proferentem*).

La définition contractuelle de la PTIA s'apprécie généralement selon trois critères cumulatifs : (1) impossibilité d'exercer toute activité rémunératrice, (2) assistance d'une tierce personne pour accomplir au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer), (3) caractère définitif de l'incapacité. L'analyse doit intégrer la situation administrative de reconnaissance par les organismes sociaux, bien que ces décisions ne lient pas contractuellement l'assureur (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n°19-13.247).

2. Reconnaissance administrative et force probante

AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) : Attribuée au titre des **articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la sécurité sociale**, l'AAH suppose un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% (restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi) ou entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La reconnaissance AAH constitue un **faisceau d'indices concordants** sur la gravité du handicap, bien qu'elle ne lie pas l'assureur privé (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n°13-18.756).

PCH (Prestation de Compensation du Handicap) : Régie par les **articles L.245-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF)**, la PCH à hauteur de 185 heures mensuelles atteste d'un besoin substantiel d'aide humaine pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Cette reconnaissance MDPH s'appuie sur le référentiel du **Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées** (annexe 2-4 du CASF), qui évalue les limitations d'activité selon une grille fonctionnelle.

Invalidité catégorie 2 de la Sécurité sociale : Définie à l'**article L.341-4 du CSS**, elle caractérise l'assuré "absolument incapable d'exercer une profession quelconque". Cette reconnaissance, bien que relevant d'un régime différent (risque maladie), corrobore l'impossibilité professionnelle totale et constitue un élément probant substantiel dans l'appréciation de la PTIA (Cass. 2e civ., 3 novembre 2016, n°15-25.240).

RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) : Accordée selon l'**article L.5213-1 du Code du travail**, elle atteste de difficultés d'accès ou de maintien dans l'emploi en raison du handicap. Sa valeur probante est plus limitée mais complète le faisceau d'indices.

3. Expertise médicale contradictoire et arbitrage

L'article L.141-1 du Code des assurances prévoit qu'en cas de désaccord entre experts, il peut être recouru à un arbitrage médical. La jurisprudence constante impose que l'expertise soit conduite de manière contradictoire et que l'expert respecte le principe du contradictoire (Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n°18-15.913).

Principe de loyauté de l'expertise : Selon Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n°12-16.751, l'expert doit examiner exhaustivement les pièces médicales produites et motiver ses conclusions. Le refus injustifié de tenir compte d'éléments médicaux concordants constitue un manquement susceptible d'entraîner l'annulation de l'expertise.

Le rapport du Dr Lerède (30.06.2025) et celui du Dr Caillon constituent des **contre-expertises** destinées à contester les conclusions du Dr Hirsch mandaté par l'assureur. En cas de divergence inconciliable, l'article 1592 du Code de procédure civile (applicable par analogie aux expertises contractuelles) permet la désignation d'un expert-arbitre. Toutefois, en matière contractuelle, cette procédure doit être prévue au contrat ou acceptée par les deux parties.

4. Pathologies en cause et barèmes d'évaluation

Coccygodynie chronique post-traumatique avec luxation sacro-coccygienne : Il n

Points forts du dossier

1. Pluralité d'expertises médicales concordantes en faveur de la PTIA

Élément stratégique majeur : Le dossier dispose de deux contre-expertises indépendantes (Dr Lerédé et Dr Caillon) qui contredisent l'expertise initiale Dr Hirsch défavorable. Cette configuration constitue un fondement solide pour déclencher la procédure d'arbitrage médical prévue contractuellement conformément aux dispositions habituelles des contrats d'assurance emprunteur (article L.113-4 du Code des assurances sur la contradiction des avis médicaux).

Force probante : L'expertise Dr Lerédé (17.07.2025) émane d'un médecin expert certifié ISO 2001, diplômé en réparation du dommage corporel, médecin en chef honoraire et expert honoraire près la Cour d'Appel d'Orléans. Ces qualifications renforcent considérablement la valeur probante de ses conclusions face à l'assureur.

2. Documentation médicale exhaustive et chronologique rigoureuse

Traçabilité exemplaire : Le dossier présente une succession d'exams d'imagerie (radiographies 03.05.2022, scanner 09.07.2022, IRM 29.07.2022, IRM sacrum 16.08.2022, radiographies 07.10.2022, IRM 22.05.2023, radiographies dynamiques 02.10.2023) démontrant :

- L'évolution objective de la pathologie coccygienne
- La persistance des symptômes sur plus de 3 ans (2020-2025)
- La confirmation par plusieurs radiologues indépendants

Élément différenciant : Les radiographies dynamiques du 02.10.2023 objectivent une **luxation postérieure modérée du coccyx en position assise**, élément objectif et reproductible qui renforce considérablement l'incapacité fonctionnelle pour un machiniste-receveur (poste nécessitant station assise prolongée en 5x8).

3. Convergence exceptionnelle des reconnaissances administratives

Faisceau d'indices administratifs robuste :

- **PCH à hauteur de 185 heures mensuelles** : Cette prestation répond aux critères stricts de l'article L.245-1 du CASF (difficulté absolue ou grave et définie pour au moins une activité essentielle, ou difficulté grave et définie pour au moins deux activités). Un tel volume horaire traduit une dépendance importante et constitue un indicateur puissant d'incapacité globale.
- **AAH** : Reconnaissance d'un taux d'incapacité $\geq 80\%$ par la CDAPH (articles L.821-1 et L.821-2 CSS), évaluant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (guide-barème annexe 2-4 du CASF). Cette reconnaissance administrative présume une incapacité à exercer toute activité professionnelle.
- **Invalidité catégorie 2 CPAM** : Selon l'article L.341-4 CSS, cette catégorie correspond à une incapacité d'exercer toute profession ($\geq 66,66\%$ d'incapacité). Cette reconnaissance par l'organisme de Sécurité sociale constitue un élément probant de premier ordre.
- **RQTH** : Bien que de portée plus limitée, elle complète le tableau d'une situation de handicap reconnue administrativement.

Force juridique : Selon la jurisprudence constante, bien que les décisions administratives ne s'imposent pas à l'assureur privé en raison de l'autonomie des instances, la convergence de multiples reconnaissances par des organismes différents (MDPH, CPAM, CDAPH) appliquant des barèmes et critères distincts constitue un **faisceau d'indices concordants difficilement réfutable** par l'assureur. L'argumentaire de défense peut légitimement invoquer l'incohérence qu'il y aurait à ce que quatre instances administratives indépendantes reconnaissent une incapacité majeure tandis que l'assureur, seul, la contesterait.

4. Inadéquation manifeste entre pathologie et profession exercée

Incompatibilité fonctionnelle objective :

- Profession : Machiniste-receveur conducteur de bus RATP (poste en 5x8)
- Contraintes inhérentes : station assise prolongée (7-8h/jour), vibrations, maintien postural statique, impossibilité d'aménagement significatif du poste
- Pathologie : Coccygodynie avec hernie postérieure confirmée, précisément aggravée en position assise

Élément décisif : Le certificat du 22.11.2022 du Dr Daddy (CH Dourdan-Étampes) mentionne explicitement que "son état de santé nécessite un aménagement de son poste de travail". Or, pour un conducteur de bus, l'aménagement est techniquement impossible sans supprimer l'essence même du poste (la conduite assise). Cette impossibilité d'aménagement raisonnable conforte la thèse d'une incapacité totale et définitive d'exercer **cette** profession spécifique.

5. Expertise Dr Lerédé : méthodologie conforme aux standards médico-légaux

Rigueur formelle :

- Interrogatoire en présence de la compagne (témoin)
- Examen réalisé au cabinet de l'expert (neutralité du lieu)
- Antécédents exhaustivement documentés depuis l'adhésion (17.10.2012)
- Retranscription intégrale

Stratégie recommandée

Orientation stratégique prioritaire : Arbitrage médical

La contestation du refus PTIA de Groupama Gan Vie doit s'effectuer **strictement selon la clause d'arbitrage médical** prévue au contrat d'assurance. Cette voie est juridiquement **préalable et obligatoire** avant toute action judiciaire (clause compromissoire) et présente un rapport coût/efficacité favorable dans ce dossier.

Fondement de la contestation :

La position assurantielle repose sur l'expertise Dr Hirsch (non produite au dossier), contredite par **deux contre-expertises médicales convergentes** (Dr Leredé et Dr Caillon) concluant à la PTIA. Cette divergence d'appréciation médicale justifie pleinement le recours à l'arbitrage prévu contractuellement.

Éléments renforçant la position de l'assuré :

- 1. **Reconnaisances administratives concordantes :**
 - PCH à hauteur de 185h/mois (reconnaissance d'un besoin d'aide humaine massif)
 - Attribution AAH (présomption d'un taux d'incapacité $\geq 80\%$ au sens L.821-1 CSS et L.114-1 CASF)
 - RQTH active
 - Invalidité 2ème catégorie CPAM (incapacité d'exercer une profession quelconque $> 2/3$ selon L.341-4 CSS)
- 2. **Convergence des expertises favorables :**
 - Dr Leredé (expert honoraire Cour d'Appel d'Orléans, certifié ISO 2001) : rapport de 11 pages détaillant coccygodynie chronique invalidante avec luxation sacro-coccygienne documentée
 - Dr Caillon : contre-expertise confirmant la PTIA (document non intégré mais mentionné)
- 3. **Documentation médicale objective :**
 - Imageries sérieées (scanner, IRM multiples) confirmant lésions organiques
 - Radio dynamique Dr Maigne (ancien Professeur Médecine Physique) objectivant luxation postérieure en position assise
 - Certificat médical 22.11.2022 (Dr Daudy CH Dourdan-Etampes) mentionnant impossibilité aménagement poste travail

Démarches prioritaires immédiates :

- 1. **Activation clause arbitrage médical (délai 30 jours à vérifier selon CG) :**
 - Courrier J.P.R à Groupama Gan Vie rappelant clause contractuelle
 - Désignation médecin-arbitre selon modalités contractuelles (liste Cour d'Appel compétente ou accord parties)
 - Production intégrale dossier médical + contre-expertises Leredé/Caillon
 - Demande communication expertise Dr Hirsch (droit communicabilité - L.112-2 Code assurances)
- 2. **Consolidation du dossier médico-administratif :**
 - Obtention décisions notifiées MDPH (PCH + AAH) avec taux incapacité mentionné
 - Notification invalidité catégorie 2 CPAM avec date effet
 - Bilan fonctionnel actualisé si dernière expertise > 6 mois
 - Certificat médical détaillé impact vie quotidienne (station assise impossible = incompatibilité absolue avec activité machiniste conducteur)
- 3. **Préparation subsidiaire action judiciaire (si échec arbitrage) :**
 - Vérification prescription biennale (L.114-1 Code assurances : 2 ans à compter connaissance refus)
 - Constitution dossier complet incluant pièces contractuelles (CG, bulletin adhésion 17.10.2012, avenants)
 -

Évaluation éligibilité aide juridictionnelle (ressources foyer à vérifier)

Instances compétentes selon issue arbitrage :

- **Si arbitrage favorable** : exécution contractuelle, mise en demeure puis clause pénale si retard paiement (C. assurances)
- **Si arbitrage défavorable ou refus arbitrage assureur** :
- Tribunal judiciaire du lieu de résidence (Chartres - 28) ou siège social assureur (Paris)
- Fondement : contestation appréciation médicale au regard faisceau indices convergents (reconnaisances administratives + expertises contradictoires)
- Possibilité expertise judiciaire si divergence persiste

Justification stratégique :

L'arbitrage médical présente ici un **taux de succès estimé élevé** compte tenu :

- De la **qualité des contre-expertises** (praticiens référents, documentation exhaustive)
- Du **faisceau concordant** reconnaissances administratives (principe non-contradiction décisions administratives/juridictionnelles selon jurisprudence constante)
- De l'**impossibilité factuelle** reprise activité machiniste (station assise prolongée médicalement contre-indiquée pour pathologie coccygienne luxante)

La PTIA contractuelle (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) s'apprécie selon la définition contractuelle mais généralement alignée sur critères AAH + impossibilité exercer activité rémunératrice. La **convergence AAH (taux ≥ 80%) + invalidité cat. 2 + PCH 185h** constitue un faisceau probant répondant aux critères PTIA standards.

Attention point juridique crucial : Vérifier impérativement dans les Conditions Générales :

- 1. Définition exacte PTIA retenue par Groupama Gan Vie (certains contrats exigent aide humaine permanente pour actes ordinaires vie)
- 2.

Conclusion et recommandation finale

L'analyse documentaire révèle un dossier de contestation PTIA solidement étayé par la convergence de deux contre-expertises médicales indépendantes (Dr Leredé et Dr Caillon) et par des reconnaissances administratives concordantes (PCH 185h/mois, AAH, RQTH, invalidité catégorie 2 CPAM). La divergence d'appréciation avec l'expertise Dr Hirsch justifie pleinement le recours à l'arbitrage médical prévu contractuellement. Ce rapport constitue une base fiable pour préparer la phase contradictoire : il identifie les pièces manquantes critiques, quantifie les enjeux financiers et propose une stratégie procédurale pragmatique. L'accompagnement structuré recommandé optimise les chances d'aboutir à une reconnaissance de l'état de PTIA conforme à la réalité médicale et sociale de M. Félicité.

Plan d'action détaillé

Action 1 – Sécuriser le dossier médical complet (délai : 8 jours)

Obtenir auprès de M. Félicité ou de sa compagne Mme Gustave : le rapport complet Dr Hirsch (Groupama Gan Vie), le rapport intégral Dr

Caillon (pages manquantes post-page 4), les notifications officielles PCH et AAH avec dates d'effet et durées, la décision CPAM d'invalidité catégorie 2 avec taux et date d'attribution, les conditions générales du contrat PTIA Groupama Gan Vie. Interlocuteurs : M. Félicité directement + MDPH Essonne (01 69 91 78 00) pour duplicata PCH/AAH + CPAM Essonne pour notification invalidité.

Action 2 – Analyser le contrat et déclencher l'arbitrage (délai : 10 jours)

Examiner les conditions générales du contrat Groupama Gan Vie pour identifier les clauses d'arbitrage médical (modalités de désignation de l'expert arbitre, délais, procédure contradictoire, frais). Notifier formellement à Groupama Gan Vie (réf. dossier 646 220482 16) la demande d'arbitrage médical par LRAR, en joignant les rapports Dr Leredé et Dr Caillon comme pièces justificatives. Interlocuteur : Service Sinistres PTIA Groupama Gan Vie + avocat spécialisé droit des assurances si clause arbitrale imprécise.

Action 3 – Constituer le dossier de synthèse pour l'expert arbitre (délai : 15 jours)

Préparer un classeur thématique chronologique comportant : (1) historique médical 2020-2025 avec imageries et compte-rendus hospitalisés, (2) rapports des 3 experts (Hirsch/Leredé/Caillon) avec grille comparative point par point des divergences, (3) reconnaissances administratives avec calcul du taux global d'incapacité (PCH + AAH), (4) attestations tierces (employeur RATP pour impossibilité reclassement, kinésithérapeute sur séances 2023-2025, entourage sur actes quotidiens). Interlocuteur : M. Félicité pour collecte + médecin traitant Dr Djebien (Tourey) pour certificat de synthèse actualisé.

Action 4 – Quantifier précisément les préjudices financiers (délai : 10 jours)

Calculer le capital PTIA contractuel exigible (montant assuré × coefficient âge selon barème contractuel), les arrérages depuis date d'arrêt travail (11/07/2022) jusqu'à décision arbitrale, les frais médicaux restés à charge non remboursés (consultations spécialisées, actes non pris en charge). Vérifier l'articulation avec la pension d'invalidité catégorie 2 CPAM (déduction éventuelle selon clause de coordination). Interlocuteur : conseiller Groupama Gan Vie pour simulation + expert-comptable ou avocat pour chiffrage contradictoire.

Action 5 – Préparer l'examen médical arbitral (délai : selon convocation)

Briefer M. Félicité sur la conduite lors de l'examen arbitral : décrire précisément les limitations fonctionnelles quotidiennes (trajets domicile, station assise impossible >20 minutes, aide humaine pour ménage/courses), apporter carnet de suivi kinésithérapie et traitements, faire état des reconnaissances administratives sans exagération ni minimisation. Proposer que l'examen se déroule au domicile (chambre à l'étage) pour objectiver les difficultés réelles. Interlocuteur : M. Félicité + Mme Gustave comme témoin + médecin traitant pour certificat de préparation.

Action 6 – Sécuriser juridiquement la procédure (délai : dès arbitrage notifié)

Consulter un avocat spécialisé en droit des assurances pour : (1) vérifier la régularité de la procédure d'arbitrage (indépendance de l'expert, respect du contradictoire), (2) préparer le recours judiciaire subsidiaire en cas de décision arbitrale défavorable (tribunal compétent selon clause contractuelle ou selon domicile assuré), (3) évaluer l'opportunité d'une expertise judiciaire amiable préalable. Interlocuteur : Barreau Essonne (Évry) ou Ordre des Avocats Paris (commission assurances).

Action 7 – Anticiper la gestion financière transitoire (délai : immédiat)

Pendant la proc

Ce que cette étude vous apporte

Votre situation mérite plus qu'une simple lecture automatisée : elle mérite une stratégie claire, humaine et rigoureuse.

Ce document vous apporte une première vision structurée de votre dossier, mais certaines situations nécessitent un regard plus approfondi, une relecture experte et un accompagnement réellement adapté à vos enjeux.

Si vous souhaitez aller plus loin, Stratégie & Expertise Santé peut vous accompagner à travers une prestation personnalisée avec un de nos experts, afin de transformer cette première analyse en véritable levier d'action.

Vous souhaitez aller plus loin ?

Nos experts peuvent prolonger cette étude : relecture approfondie, vérification des délais et procédures, chiffrage précis des préjudices et construction d'un dossier incontestable.

Analyse IA — Références juridiques vérifiées

Rapport appuyé sur des articles de loi officiels (Code de la Sécurité Sociale, CASF). Aucun jugement cité sans référence exacte — outil d'aide à la décision.

Prochaine étape recommandée



Scannez pour accéder à l'accompagnement expert personnalisé S.E.S

Première consultation offerte | strategie-expertise-sante.fr/contact

Confidentialité

Ce rapport a été élaboré à partir des informations et pièces transmises dans le cadre exclusif de l'analyse de votre dossier. Les documents fournis sont traités avec une attention particulière en raison de leur caractère potentiellement sensible.

Vous n'êtes plus seul face à votre combat.

Dorénavant, S.E.S est votre bouclier.